PROTOCOLLO 27

Scivolamento mediale e laterale dell'ATM

Recuperare la mobilità in lateralità

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Lateralità ridotta da un lato
- ✓ Deviazione persistente in apertura
- ✓ Rigidità capsulare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo



Presa
Pollice sui molari, palmo esterno sul ramo mandibolare.



Distrazione
Leggera distrazione caudale di partenza.



Scivolamento
Spinta mediale o laterale controllata secondo la limitazione.



Verifica
Misura la lateralità dopo ogni serie.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Direzione	verso il movimento limitato

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	**____ / 10**	**Retta / Deviata**
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Lavora nella direzione della restrizione
- ✓ Mantieni la stabilizzazione cranica
- ✓ Associa esercizi di lateralità attiva

Errori da evitare

- ! Forza eccessiva in lateralità
- ! Trascurare il lato controlaterale
- ! Assenza di rivalutazione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Lateralità attiva	Scivolare la mandibola di lato con un abbassalingua tra i denti	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La lateralità di riferimento supera i 7 mm per lato; misurala sempre prima e dopo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.